חלק שישי | מודול 8

מדריך למשפחה:

דיור מוגן, בתי אבות ואשפוז

כל מה שבני משפחה צריכים לדעת – ברור, קצר ומונגש

- בחירת מסגרת לפי תפקוד ובריאות
- מימון וזכויות (משרד הבריאות, רווחה, ביטוח לאומי)
- שיקום רפואי – מימוש זכויות ולוחות זמנים
- כלים מעשיים: צ'ק-ליסטים, חוזים וטפסים



מתי לשקול מעבר מהבית?

5 סימני אזהרה מרכזיים המעידים כי הגיעה העת לשקול מסגרת מוגנת:

ירידה תפקודית משמעותית

קושי בביצוע פעולות יום־יום (ADL), נפילות חוזרות וירידה בניידות.

צורך בטיפול רפואי צמוד

מצבים הדורשים השגחה 24/7, מתן תרופות מורכב או ניטור רפואי קבוע.

סיכון בטיחותי בבית

שכחת גז דולק, בלבול בזמנים, שיטוט מחוץ לבית ללא התמצאות.

בדידות וחסך חברתי

דיכאון הנובע מבידוד, חוסר בגירויים חברתיים ומנטליים בבית.

שחיקת המטפלים במשפחה

עומס פיזי ונפשי כבד על בני המשפחה המטפלים, הפוגע בבריאותם ובמרקם המשפחתי.

טיפ: לעיתים קרובות, בני המשפחה הם האחרונים להבחין בחומרת המצב עקב ההרגל. הקשיבו גם לפידבק חיצוני (רופא, שכנים).

מפת המוסדות לפי רמת תפקוד

התאמת המסגרת ומסלול המימון נקבעים לפי הסטטוס התפקודי והרפואי:

רמת תפקוד	מסגרת מתאימה	מי ממן?
עצמאי	**דיור מוגן / מקבץ דיור** ניהול משק בית עצמאי	פרטי · משרד השיכון (זכאים)
תשוש	**מעון לזקנים / מחלקת תשושים** עזרה חלקית בפעולות	פרטי · משרד הרווחה (מבחן הכנסות)
סיעודי	**מחלקה סיעודית** עזרה מלאה + השגחה 24/7	פרטי / ביטוח סיעודי · משרד הבריאות ("קוד")
תשוש נפש	**מחלקה לתשושי נפש** דמנציה / אלצהיימר (מחלקה סגורה)	פרטי / ביטוח סיעודי · משרד הבריאות ("קוד")
סיעודי מורכב	**מחלקה סיעודית מורכבת** פצעי לחץ עמוקים / הנשמה	**קופת החולים בלבד**
שיקום	**מחלקה לשיקום / גריאטריה שיקומית** לאחר אירוע חריף (שבץ/שבר)	**קופת החולים (ללא עלות)**

השוואת עלויות 2026 (טווחים משוערים)

דיור מוגן

₪10k - 18.5k

לחודש (דמי אחזקה)

- **פיקדון:** גבוה (מאות אלפים עד מיליונים)
- משתנה לפי אזור וגודל דירה
- לא כולל טיפול סיעודי מלא

בית אבות לתשושים

₪7k - 14k

לחודש

- עזרה חלקית בלבד
- סיוע אפשרי ממשרד הרווחה
- תלוי ברמת השירותים והחדר

סיעודי / תשוש נפש

₪13k - 28k

לחודש (פרטי מלא)

- **סטנדרטי:** 13k-22k
- **מורכב/מחלקה סגורה:** 14k-28k
- ב"קוד" משרד הבריאות: כולל הכל (חיתולים, תרופות)

שיקום רפואי

₪0 (ללא עלות)

במימון קופת חולים

- אורתופדי: מינימום 14 יום
- נוירולוגי: מינימום 25 יום
- כולל אשפוז מלא וטיפולים

גורמי השפעה על המחיר:

מיקום גיאוגרפי | מספר דיירים בחדר | מורכבות הטיפול | שירותי פרימיום

שים לב: מוסדות יוקרתיים ופרטיים עשויים לחרוג משמעותית מהטווחים המצוינים מעלה.

שיקום רפואי – זכויות וזמנים

שיקום רפואי – זכות חוקית, ✅ בחינם!

מקור: חוק ביטוח בריאות ממלכתי

מתי זכאים לשיקום?

- **לאחר אירוע חריף:** שבץ מוחי (CVA), שבר בצוואר הירך, ניתוח אורתופדי מורכב.
- **ירידה תפקודית חדה:** בעקבות אשפוז ממושך (דלקת ריאות, זיהום) או מחלה קשה.
- **צוות רב-מקצועי:** פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת, עו"ס ופסיכולוג.

הזכות ניתנת למימוש באשפוז או בקהילה, בהתאם למצב הרפואי.

חלון הזדמנויות
חייב להתחיל מיד לאחר האשפוז האקוטי

מינימום ימים
14 יום (אורתופדי)
25 יום (נוירולוגי)

גם בקהילה
שיקום בית, מרכז יום או מכונים בקהילה

זמן תגובה
קופ"ח חייבת להשיב תוך **48 שעות** (2 ימי עבודה)

סירוב לשיקום?
זכותכם לערער! פנו לפניות הציבור בקופה או במשרד הבריאות (*5400).

מימון וזכאות – 5 ערוצים עיקריים

המימון נקבע בהתאם לסטטוס הרפואי והכלכלי. להלן הערוצים המרכזיים:

ערוץ מימון	מה מקבלים? (הטבה / סיוע)	לאן פונים?
משרד הבריאות	**"קוד אשפוז":** מימון מלא לסיעודי/תשוש נפש (בניכוי השתתפות עצמית של המשפחה).	לשכת הבריאות המחוזית
משרד הרווחה	סיוע במימון בתי אבות **לתשושים/עצמאיים** מעוטי יכולת (בכפוף למבחן הכנסות).	המחלקה לשירותים חברתיים
משרד הביטחון	**משפחות שכולות/נכים:** מענק אשפוז עד **42,365 ₪** (נכון ל-2025).	מוקד משרד הביטחון
ביטוח לאומי	**גמלת סיעוד:** ניתנת בבית/דיור מוגן. **לא ניתנת באשפוז במוסד!**	אתר המוסד לביטוח לאומי
ביטוח פרטי	מימון או שיפוי בהתאם לפוליסת סיעוד פרטית (בדקו החרגות וזמני המתנה).	סוכן הביטוח / החברה

שים לב: במוסד במימון "קוד" (משרד הבריאות), המוסד חייב לספק תרופות וחיתולים. **אסור** לגבות מהמשפחה תשלום נוסף על ציוד בסיסי זה!

במשרד הבריאות יש מחשבון זכאות

תהליך הבחירה – 5 צעדים מעשיים

מסלול מובנה למעבר בטוח ונכון למוסד המתאים ביותר ליקירכם:

קביעת סטטוס רפואי

פנייה ללשכת הבריאות ("קוד").

כ-14 ימים

איתור מוסדות

חיפוש במאגרים רשמיים והתאמה לצרכים.

ng-homes.health.gov.il

ביקורי התרשמות

שיחות עם הצוות, דיירים ומשפחות. בדיקת ניקיון ואווירה.

מומלץ: 3 מוסדות

הגשת בקשה

איסוף מסמכים רפואיים וכלכליים + חתימת 2 ערבים.

מבחן הכנסות

חתימה ומעבר

בדיקת חוזה קפדנית, חתימה וקליטה במוסד.

קבלת מפתח

טיפ חשוב: התחילו את התהליך מוקדם ככל האפשר. רשימות ההמתנה למוסדות הטובים עשויות להיות ארוכות, ואיסוף המסמכים לוקח זמן.

מה לבדוק בחוזה? צ'ק-ליסט קצר

לפני שחותמים, ודאו שקיבלתם תשובות ברורות וכתובות לכל הסעיפים הבאים:

מחיר בסיס ותוספות
מה בדיוק כלול? (כביסה, חוגים, פיזיותרפיה). מה בתוספת תשלום?

מדיניות חופשות ואשפוז
האם משלמים כשנמצאים בבית חולים או בחג בבית? לכמה זמן נשמרת המיטה?

תרופות וציוד מתכלה
מי משלם על תרופות, חיתולים, וציוד היגיינה? (קריטי בעלויות!)

תנאי סיום ועזיבה
הודעה מוקדמת, החזר פיקדון (אם יש), קנסות יציאה.

עליית רמת טיפול
מה קורה למחיר אם המצב מידרדר (תשוש > סיעודי)? האם יש התחייבות למקום?

רישיון תקף
בדיקת רישיון בתוקף ממשרד הבריאות/הרווחה התואם למחלקה.

שים לב: איסור חיוב נוסף ("קוד")

במוסד במימון משרד הבריאות, המוסד מחויב לספק את כל הציוד הרפואי והמתכלה. אין לשלם בנפרד!

מוסד ללא רישיון = סכנה

לעולם אל תחתמו עם מוסד שאינו מפוקח ואין לו רישיון בתוקף.

שיחה עם הורה מתנגד – 3 גישות עובדות

התנגדות היא טבעית ומגיעה מפחד. הנה שלוש אסטרטגיות לריכוך ושיח מכבד:

תקפו את הרגש

"אני שומע שאתה מפחד, וזה באמת שינוי לא פשוט. אנחנו נעבור את זה יחד."

במקום להתווכח עם עובדות ("אבל מסוכן לך בבית"), הכירו ברגש שלו. זה מוריד התנגדות ופותח הקשבה.

תנו שליטה בקטנות

"איזה תמונות תרצה לקחת איתך? באיזה יום תעדיף שנלך לראות את המקום?"

כשההורה מרגיש שהוא מאבד את הבית, תנו לו שליטה על הפרטים הקטנים. זה מחזיר תחושת ערך ועצמאות.

שתפו דיירים קיימים

"בוא נשמע מדוד משה איך הוא הסתדר בהתחלה."

דיירים מרוצים הם השגרירים הטובים ביותר. הפחד הגדול ביותר הוא מהלא נודע - הם ההוכחה שאפשר אחרת.

במקרה של דמנציה: "אמת טיפולית"

אין טעם בעימות לוגי. השתמשו במסרים מרגיעים שמתאימים למציאות שלו: "אנחנו הולכים למקום שבו יבדקו שהכל בסדר איתך ואז נראה", במקום "אתה עובר לבית אבות לתמיד".

ניהול משפחתי הוגן – חלוקת תפקידים

חלוקת עומס נכונה מונעת שחיקה וסכסוכים. מומלץ למנות אחראי לכל תחום:

התחום הרפואי

- קשר שוטף עם הצוות והרופא
- מעקב תרופות ושינויים במצב
- ליווי לבדיקות חיצוניות

התחום הלוגיסטי

- ארגון המעבר והובלת הציוד
- התאמת החדר ורכישת חוסרים
- טיפול בדירה הישנה (שכירות/מכירה)

התחום הכספי

- ניהול חשבון בנק ותשלומים למוסד
- מיצוי זכויות (ביטוח לאומי, מס הכנסה)
- מעקב אחר הוצאות ותקציב

התחום הרגשי-חברתי

- תיאום ביקורי משפחה ונכדים
- שמירה על קשר עם חברים מהעבר
- תמיכה רגשית בהורה ובאחים

טיפ: היעזרו בטופס "חלוקת תפקידים" המצורף בערכה כדי להגדיר מי עושה מה ולמנוע אי-הבנות. מומלץ לקיים "ישיבת צוות" משפחתית אחת לחודש.

תיק מידע לצוות – מה חשוב לכלול?

הצוות הרפואי והסיעודי מתחלף במשמרות. "תיק המידע" הוא הקול של ההורה כשאתם לא שם:

רפואי ותפקוד

- ✓ סיכום רפואי עדכני + רשימת תרופות ורגישויות
- ✓ תפקוד יומיומי: רמת עצמאות בהליכה, אכילה ורחצה
- ✓ הרגלי שינה ושעות מנוחה מועדפות

קשר ומשפחה

- ✓ מפת קשרים משפחתיים: שמות ילדים ונכדים + תמונות
- ✓ איש קשר ראשי לחירום (זמין 24/7)
- ✓ מסמכים משפטיים: ייפוי כוח רפואי / אפוטרופסות

האדם שמאחורי המטופל

- ✓ העדפות אישיות: מוזיקה אהובה, מאכלים, תחביבים
- ✓ מה מרגיע? (ליטוף יד, שיר מסוים, תמונה)
- ✓ טריגרים ופחדים: רעש חזק, חושך, דלתות סגורות

ציוד אישי לחדר

- ✓ בגדים נוחים ומסומנים בשם (למניעת אובדן בכביסה)
- ✓ כלי רחצה מוכרים, משקפיים, מכשיר שמיעה
- ✓ חפץ אישי מהבית: כרית אהובה, שעון, תמונה משפחתית

למה זה קריטי? מידע אישי עוזר לצוות לראות את ההורה כ"אדם" ולא רק כ"מטופל", ומאפשר להם להעניק יחס אישי ומותאם יותר, במיוחד ברגעי משבר או בלבול.

מפת דרכים – רשימת טפסים

להלן רשימת הטפסים המלאה שתלווה אתכם בתהליך. כל הטפסים זמינים להורדה מרוכזת באתר הקורס:

אשפוז סיעודי ("קוד")

1. טופס בקשה לסידור מוסדי (משרד הבריאות)
2. מידע רפואי סיעודי-תפקודי (רופא/אחות)
3. דו"ח פסיכו-סוציאלי (עובד/ת סוציאלי/ת)
4. שאלון הצהרה למטופל/בן זוג (מבחן הכנסות)
5. שאלון הצהרה לילדים בגירים
6. כתב התחייבות לתשלום חודשי + ערבים

כלי עבודה מהקורס

7. צ'ק-ליסט לבחירת מוסד (מה לשאול בסיור)
8. טבלת השוואת מוסדות (יתרונות/חסרונות)
9. תבנית "תיק מידע לצוות" (דף פרופיל אישי)
10. רשימת ציוד מומלצת למעבר (בגדים/אישי)
11. פרוטוקול שיחת משפחה (ניהול דיון)

ניהול משפחתי ומשפטי

12. ייפוי כוח רפואי / מתמשך (עותק מאושר)
13. טופס ויתור סודיות רפואית
14. בקשה לגמלת סיעוד (ביטוח לאומי)
15. טופס חלוקת תפקידים בין אחים

כל 15 הטפסים זמינים להורדה כקובצים באתר הקורס.

רשימות בתי אבות - קישורים מרכזיים

לפני שיוצאים לסיורים, מומלץ לבדוק במאגרים הרשמיים והארציים:

המאגר הרשמי - משרד הבריאות

nursing-homes.health.gov.il

איתור מוסדות בעלי רישיון תקף בלבד. כולל סינון לפי סוג מחלקה, אזור, וציון מדדי איכות של משרד הבריאות.

רשימת בתי אבות ארצית

israel-homes-for-the-aged.com

פורטל המרכז רשימות לפי יישובים וערים בכל הארץ, כולל מוסדות סיעודיים, תשושי נפש ובתי אבות לעצמאיים.

בתי אבות בתל אביב והמרכז

berti.co.il/batei-avot-tel-aviv

מיקוד באזור המרכז ותל אביב, עם פירוט על מחלקות סיעודיות ופתרונות דיור מוגן ספציפיים לאזור זה.

חשוב לדעת לפני שמתחייבים!

בדקו תמיד את תוקף הרישיון במאגר הממשלתי. לחישוב עלויות השתתפות עצמית ("קוד"), היעזרו במחשבון הרשמי: **nursingcalculator.health.gov.il**

מוקדים ומספרי חירום

שמרו את המספרים האלו בנייד. הם הכתובת שלכם לכל שאלה, זכות או התייעצות:

מוקד לאזרחים ותיקים
8840*

קול הבריאות (משרד הבריאות)
5400*

המוסד לביטוח לאומי
6050*

ייעוץ לקשיש ומשפחתו (חינם)
9696*

שי"ל (שירות ייעוץ לאזרח)
118

מענה ממשלתי מרכזי
1299

טיפ חשוב: בזמן אשפוז בבית חולים, חפשו את "יחידת סגולה" – מוקד ייעודי למיצוי זכויות המאושפז ובני משפחתו.

"אתם לא לבד – קבלת עזרה מקצועית היא חוכמה, לא חולשה"